UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

IUT Grand Ouest Normandie – Pôle d'Alencon

MÉMOIRE DE SPÉCIALITÉ

3ème année de BUT Carrières Sociales
Parcours Coordination et Gestion des Etablissements et Services Sanitaires et Sociaux

Livrable 3

« La Gestion des ESSMS (Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux) »

L'impact démographique du vieillissement sur l'évolution des besoins sociaux et sanitaires

Présenté par : **Nadila RAKHMADWITA**

Tutrice universitaire : **Mme. Clara AOUN, Maître de conférences en sciences de gestion, Management des Ressources Humaines, IUT d'Alençon**

SOMMAIRE

Introduction

Hypothèses

Problématique

Méthodologie

I. Le vieillissement et perte d'autonomie : un facteur de transformation des besoins

A. Les enjeux du vieillissement

B. Etat de lieux de la population sur la zone rurale de l'orne

C. Les orientations des politiques publiques

II. La prise en charge des résidents en institution d'hébergement

A. Des conditions de travail de plus en plus exigeantes

B. L'évolution des besoins des résidents

C. L'importance du rôle de l'encadrement

III. Les leviers d'adaptation de la gestion

A. Développement des compétences et professionnalisation

B. Renforcement du rôle des directions

C. Coordination et amélioration de la qualité

Introduction

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) met en avant un changement important dans notre société, la population mondiale vieillit de plus en plus vite. L'allongement de l'espérance de vie des personnes âgées en France n'a cessé d'augmenter. En 2025, le dernier bilan démographique de l'Insee marque pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de décès que de naissances. Ce bilan montre que la France entre dans une nouvelle phase démographique, il y a moins de naissances, cependant il y a plus de personnes âgées et plus de décès. Nous pouvons constater que, même si les Français vivent plus longtemps qu'avant, ils sont aussi beaucoup plus nombreux à être âgés et vivre avec des pathologies chroniques liées au grand âge ou de vivre dans une condition état de santé altéré. Ce qui peut entraîner des situations de fragilité et conduire à une perte d'autonomie. (Horvath, G. et Touzé, V. (2024)). Ce changement pose des défis importants pour l'avenir, notamment pour la santé, la protection sociale et l'organisation de la société face au vieillissement de la population. Face à ce phénomène, les pouvoirs publics, les acteurs associatifs et les entreprises du secteur essaient de mieux répondre aux besoins croissants des personnes âgées, particulièrement dans la prise en charge de soins et/ou de l'accompagnement acte quotidien des *personnes âgées*.

Selon les projections démographiques de l'Insee reprises par l'Ined, la population française devrait continuer à vieillir significativement au cours des prochaines décennies. Le vieillissement est particulièrement marqué dans les tranches d'âge les plus élevées. Ce sont du nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus devrait doubler d'ici 2070 (Population et Sociétés, n° 597, Ined (2022)). Alors, la hausse attendue des 75 ans et plus, 8% des seniors touchés par la perte d'autonomie, 10% des plus de 75 ans résident en établissement. Ces données représentent non seulement un enjeu sociétal majeur, mais aussi un coût significatif pour la collectivité. En effet, la prise en charge en établissement est la plus coûteuse car, elle inclut « un seul prix mais trois prestations : l'hébergement, les soins, et la dépendance[1] ». Le département finance en partie par la branche autonomie de la sécurité sociale, il verse des prestations aux personnes âgées résidant en établissement. Cette reflète souligne la nécessité d'une réflexion approfondie sur les modes de gestion d'accompagnement des personnes âgées. Dans ce contexte, les établissements hébergeant des personnes âgées, sont répartis entre trois types d'acteurs (non médicalisé, semi-médicalisé ou médicalisé) : le secteur public, qui assure la gestion de plus de 50% de places en EHPAD. Le secteur privé non lucratif, responsable

[1] https://www.lepelerin.com/france/societe/pourquoi-la-note-est-si-elevee-8530

d'environ 30% de l'offre, et le secteur privé lucratif, qui couvre 20% des capacités d'accueil. (Arnal-Capdevielle, I. (2020)).

Lors de la crise du COVID-19, la prise en charge des personnes âgées en établissement ont révélé les fragilités de la qualité de leur accompagnement. La Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 et le Ségur de la santé (2020), s'inscrivent viser à garantir d'améliorer les conditions de travail et de qualité de vie dans l'ensemble des milieux professionnels publics et privés en revalorisant les métiers du secteur. Elle repose sur une approche globale et coordonnée mobilisant de nombreux ministères et acteurs, avec un suivi annuel et une évaluation régulière. Cette stratégie met en avant des priorités, notamment le développement de la prévention, l'amélioration de la qualité de vie au travail et le renforcement de la coordination entre les différents acteurs. Dans le contexte du vieillissement de la population et de l'évolution des besoins sociaux et sanitaires, la SNS encourage le renforcement de l'accompagnement des personnes atteintes de pathologies chroniques et neurodégénératives, ainsi que la promotion de parcours de soins favorisant l'autonomie. Elle s'appuie au développement des solutions de mobilité, en soutenant des organisations territoriales coordonnées, par les agences régionales de santé. La population âgée présente majoritairement une perte d'autonomie importante. Dans ce contexte, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) occupent une place centrale. Parmi les hébergements de personnes âgées, les besoins sont donc davantage orientés vers un accompagnement médicalisé et permanent. Les Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) répondent à ces besoins, contrairement aux Résidences Autonomie qui accueillent des personnes plus autonomes constituent un terrain particulièrement pertinent d'analyse. À la fois lieux de soins et de vie, ils sont confrontés à des exigences multiples : qualité de l'accompagnement, contraintes budgétaires, pénurie de personnel et évolution des profils des résidents.

Hypothèses :

1. Les difficultés de recrutement et le manque de reconnaissance des métiers du grand âge qui fragilisent l'organisation interne des établissements d'hébergement de personnes âgées.
2. La complexité des conditions de travail (charge mentale, pénibilité, instabilité des plannings) et l'évolution des besoins des résidents rendent nécessaires le développement des compétences professionnelles
3. Le rôle des directions et des cadres est essentiel pour assurer la qualité de la prise en charge et la coordination des équipes.

Problématique : la problématique de cette recherche est la suivante : Face à la transformation du secteur, comment les ESMS répondent-ils aux besoins des personnes âgées ?

État de l'art

L'analyse du vieillissement démographique constitue le point de départ de nombreuses recherches en sciences sociales et en action médico-sociale. En France, le vieillissement de la population résulte principalement de l'allongement de l'espérance de vie et de la baisse durable de la fécondité. Toulemon et al. (2022) montrent que cette dynamique est structurelle et qu'elle se traduira par une augmentation continue du nombre de personnes âgées, en particulier dans les tranches d'âge les plus élevées. Toutefois, les travaux scientifiques souligne qu'il serait réducteur d'assimiler vieillissement et dépendance. Si l'avancée en âge accroît la probabilité de perte d'autonomie, celle-ci ne constitue ni une fatalité ni une réalité homogène. Cette distinction est essentielle pour comprendre l'évolution des besoins sociaux et sanitaires, qui se caractérisent davantage par une complexification que par une simple augmentation quantitative. Progressivement, les travaux ne se sont plus limités à une approche démographique du vieillissement, mais ont intégré ses dimensions sociales, professionnelles et politiques. Artois, Hamzaoui et Léonard (2017) analysent le vieillissement comme un fait social (Durkheimien) qui reconfigure les catégories d'action publique, les formes de travail et les politiques sociales. Selon ces auteurs, l'accompagnement des personnes âgées s'inscrit désormais dans des logiques institutionnelles marquées par la recherche d'efficacité, la standardisation des pratiques et la montée des exigences de qualité. Cette évolution modifie profondément les conditions de travail dans le secteur social et médico-social, en particulier dans les établissements accueillant des personnes âgées en perte d'autonomie. Dans ce contexte, les Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux occupent une place centrale. Définie par le Code de l'action sociale et des familles (du CASF), les ESSMS regroupent des structures aux missions diverses, mais partageant une même finalité d'accompagnement de publics vulnérables. Les EHPADs constituent une catégorie spécifique de ces établissements, caractérisée par leur dimension à la fois sociale et sanitaire. Cocquebert (2012) souligne que cette hybridation constitue une source majeure de tensions organisationnelles, dans la mesure où les EHPAD doivent concilier des logiques parfois contradictoires : logique de soins, logique d'accompagnement social et logique gestionnaire. La loi HPST a renforcé ces tensions en introduisant de nouveaux modes de gouvernance, de contrôle et de financement, accentuant les exigences pesant sur les directions d'établissements. La transformation des publics accueillis en EHPAD accentue encore cette complexité. Le vieillissement s'accompagne d'une augmentation des pathologies chroniques,

des troubles cognitifs et des situations de dépendance lourde, ce qui renforce la nécessité d'un accompagnement global et coordonné. Cette évolution explique la montée en importance de l'interprofessionnalité, entendue comme une coopération structurée entre professionnels aux compétences, statuts et cultures professionnelles différentes. L'interprofessionnalité suppose des formes de coordination, de reconnaissance mutuelle et de régulation des rôles. Les travaux d'Artois et al. (2017) montrent que cette coopération est devenue indispensable dans le secteur du vieillissement, tout en générant des tensions liées aux rapports de pouvoir et aux cultures professionnelles. Face à ces transformations, le rôle des directeurs et des cadres de santé en EHPAD connaît une évolution significative. Loubat (2020) met en évidence le fait que le management en ESSMS ne peut plus se réduire à une fonction administrative ou réglementaire. Les directions sont désormais appelées à jouer un rôle de médiation et de régulation, devant articuler les exigences institutionnelles, les contraintes budgétaires, les attentes des professionnels et les besoins des personnes accompagnées. Passerat et Benoit (2022) soulignent que ces fonctions requièrent des compétences managériales élargies, incluant la gestion des ressources humaines, la communication, la conduite du changement et la prise en compte des dimensions éthiques de l'accompagnement. Ces enjeux managériaux prennent une dimension particulière lorsqu'ils sont analysés à l'échelle territoriale. Le territoire ne constitue pas seulement un cadre géographique, mais un ensemble de ressources, d'acteurs et de contraintes qui influencent fortement le fonctionnement des ESSMS. Horvath et Touzé (2024) montrent que le vieillissement accentue les inégalités territoriales, notamment en matière d'accès aux soins et de disponibilité des professionnels de santé. Dans les territoires marqués par la désertification médicale, les EHPAD doivent développer des stratégies spécifiques de coopération et d'adaptation organisationnelle afin de garantir la continuité de l'accompagnement. Le territoire apparaît ainsi comme un facteur structurant de la gestion des ESSMS, conditionnant les marges de manœuvre des directions et les modalités de collaboration interprofessionnelle. La centralité des enjeux de gestion, et de territorialisation, tout en laissant en partie dans l'ombre les pratiques concrètes des acteurs de direction face à ces transformations. C'est précisément à ce niveau que s'inscrit cette recherche, en cherchant à comprendre comment les directeurs et cadres de santé traduisent, dans leurs pratiques quotidiennes.

Dès les années 2010, la question du vieillissement est analysée comme un phénomène structurel modifiant en profondeur les politiques sociales. Cocquebert (2012) met en évidence l'impact de la loi HPST sur la gouvernance des établissements sociaux et médico-sociaux, soulignant un

renforcement du contrôle institutionnel et une rationalisation de la gestion, qui influencent directement l'organisation des EHPAD.

Parallèlement, les recherches sociologiques, notamment celles d'Artois, Hamzaoui et Léonard (2017), montrent que le vieillissement ne se limite pas à une évolution démographique, mais qu'il s'accompagne de processus de catégorisation sociale et de transformations du travail médico-social. Ces auteurs insistent sur la montée des exigences professionnelles et sur la nécessité de coopérations accrues entre acteurs.

Dans les années 2020, les analyses se concentrent davantage sur les enjeux managériaux. Loubat (2020) développe une réflexion approfondie sur le management en action sociale et médico-sociale, soulignant l'importance d'un management adaptatif, centré sur les compétences, la coordination des équipes et la qualité de l'accompagnement. Passerat et Benoit (2022) confirment cette évolution en montrant que les fonctions de direction intègrent désormais des compétences transversales, allant bien au-delà de la gestion administrative.

Plus récemment, Horvath et Touzé (2024) analysent les conséquences économiques et sociales d'une vieillissante, en mettant en avant le défi majeur de la perte d'autonomie. Ils soulignent que les EHPAD se situent au cœur de cette problématique, devant articuler *enjeux financiers, qualité des soins* et *adaptation aux besoins des usagers*. Enfin, les travaux démographiques de Toulemon et al. (2022) fournissent un cadre chiffré essentiel, confirmant que le vieillissement de la population va s'intensifier, rendant incontournable une réflexion sur l'évolution des ESSMS et de leurs modes de gestion.

Terrain et professionnels enquêtées

Le terrain d'étude est constitué de résidence d'hébergement de personnes âgées, implantés sur un territoire de l'Orne en zone rurale (Alencon, Sées, Conde sur Sarthe).

La population enquêtée comprend :

- Des directeurs ou directrices d'EHPAD,
- Des cadres de santé
- Professionnels des résidences

Un échantillon prévisionnel de 5 à 8 entretiens semi-directifs est envisagé, permettant une diversité de points de vue.

Outils de collecte de données

Les données seront recueillies par :

- Des entretiens semi-directifs, à partir d'un guide d'entretien structuré autour de plusieurs axes :
- Évolution du public accueillie,
- Organisation du travail et coopération interprofessionnelle,
- Compétences managériales mobilisées,
- Contraintes territoriales et partenariales.

Des données complémentaires pourront être mobilisées à partir de période de stage du S6.

Calendrier prévisionnel

- **Décembre - Janvier :** Prise de contact
- **Janvier - Février** : Réalisation des entretiens
- **Mars :** Retranscription et analyse des données
- **Avril :** Rédaction du mémoire
- **Mai :** Relectures et finalisation

Grille des acteurs contactés

Organismes	Fonction	Prise de contacts
EHPAD de la Miséricorde	Directeur Cadre de santé	
EHPAD de l'Hôpital Sées	Directrice	Email envoyé
EHPAD ANAIS de Sées	Directrice	Email envoyé
Résidence Autonomie Le Clair Matin	Directrice	Email envoyé 22/04 à 09h00

Résidence Arpège Condé sur Sarthe	Directrice	Email envoyé 19/02 à 17h00
EHPAD La Rimblière	Directrice	Email envoyé 20/02 à 17h00
Résidences Escalys Saint Germain du Corbéis	Direction	Email envoyé 14/04 à 17h00
E.H.P.A.D. "Le Diamant" KORIAN	Directeur	Email envoyé
E.H.P.A.D. "Résidence La Sénatorerie"		Email envoyé
CENTRE HOSPITALIER "Les Pastels"	Directeur	Email envoyé
CENTRE HOSPITALIER E.H.P.A.D.	Directeur	Email envoyé
Cliniques de rééducation pour les personnes âgées	Directeur	17/02 à 17h00

Analyse des résultats de l'entretien

Cliniques de rééducation pour les personnes âgées

Tout d'abord, le profil du directeur interrogé apparaît comme un élément déterminant. Son expérience importante, associée à une formation continue de haut niveau (ESSEC), traduit une professionnalisation accrue des fonctions de direction.

Ensuite, l'organisation de la gouvernance repose sur une logique participative, notamment à travers le comité de direction (CODIR). Cette structuration favorise la coordination et la prise de décision partagée, mais elle tend également à limiter l'exercice d'une autorité strictement verticale. Le rôle de la hiérarchie intermédiaire, en particulier au niveau régional, apparaît ainsi central dans la déclinaison des orientations stratégiques.

Par ailleurs, les compétences managériales se caractérisent par leur dimension multidimensionnelle. Le directeur doit conjuguer des missions de gestion, de management et de qualité, tout en mobilisant des compétences informelles issues de l'expérience. Cela confirme que l'adaptation aux transformations du secteur repose autant sur les savoirs formels que sur les savoirs expérientiels.

L'implication des professionnels constitue également un levier majeur. Les dispositifs institutionnels (instances, entretiens annuels, communication interne) favorisent l'engagement collectif et participent à la structuration du travail. Toutefois, cette implication s'inscrit dans un cadre organisationnel fortement contraint.

En effet, l'analyse met en évidence une tension structurelle entre logique économique et logique de soin. L'objectif de rentabilité, illustré par la comparaison avec un modèle hôtelier, peut entrer en contradiction avec les exigences de qualité de l'accompagnement. Cette tension constitue un enjeu central du secteur médico-social.

Enfin, plusieurs leviers et freins à l'amélioration sont identifiés. Si la formation, la communication et le travail en équipe apparaissent comme des facteurs favorables, les contraintes institutionnelles, la fatigue des professionnels et l'image dégradée du secteur limitent les marges de manœuvre.

Ainsi, l'entretien montre que les compétences managériales et la structuration de l'organisation constituent des leviers essentiels d'adaptation, mais qu'elles restent fortement conditionnées par des contraintes structurelles et territoriales.

EHPAD La Rimblière

Le deuxième profil est la directrice interrogée se distingue par une reconversion professionnelle récente. Ce parcours atypique illustre une diversification croissante des profils accédant aux fonctions de direction. Cette évolution témoigne d'une transformation du métier, qui ne repose plus uniquement sur des trajectoires classiques du secteur médico-social, mais s'ouvre à des compétences transversales.

Ensuite, l'organisation de la gouvernance repose sur une logique collective, structurée autour d'un comité de direction restreint. La prise de décision est décrite comme partagée, ce qui traduit une évolution vers des formes de management participatif. Cette organisation favorise la coordination des équipes, tout en renforçant la responsabilisation des cadres intermédiaires, chacun étant en charge de son périmètre.

Par ailleurs, la question des compétences apparaît centrale. L'exigence de qualification, notamment à travers le diplôme D3S, traduit une professionnalisation accrue des fonctions de direction. Toutefois, cette exigence se heurte à la réalité du terrain, marquée par une pénurie de personnel qualifié. L'établissement développe ainsi des stratégies d'adaptation, notamment par la formation des agents non diplômés et l'acceptation de compromis organisationnels.

L'analyse met également en évidence les difficultés liées à la conduite du changement. La résistance des professionnels, l'inertie des organisations et la rigidité des plannings constituent des freins importants. À cela s'ajoutent les contraintes du quotidien, marquées par la gestion des urgences, qui limitent la capacité à mettre en œuvre des projets à long terme.

Cependant, certains leviers apparaissent clairement. Le travail en équipe de direction, la mise en place de démarches qualité et le développement d'une communication structurée contribuent

à améliorer la gestion. Le collectif joue ainsi un rôle central dans la réussite des transformations organisationnelles.

Enfin, l'entretien souligne un contexte d'incertitude lié aux évolutions du secteur, notamment avec le « virage domiciliaire ». Cette transformation interroge le rôle futur des EHPAD et renforce la nécessité d'adaptation des pratiques professionnelles.

Résidence Arpège Condé sur Sarthe

L'analyse de cet entretien met en évidence un profil de direction fortement professionnalisé, caractérisé par un parcours académique cohérent avec les exigences du secteur médico-social. La combinaison d'une formation juridique, d'une formation en ingénierie sociale et du CAFDES témoigne d'une préparation spécifique aux fonctions de direction en ESSMS. Ce type de parcours confirme la montée en qualification des dirigeants, déjà observée dans les entretiens précédents.

Par ailleurs, la directrice occupe une position stratégique au sein de l'établissement, impliquant des responsabilités importantes en matière de gestion, d'organisation et de prise de décision. Cette centralité du rôle de direction renforce l'idée que les compétences managériales constituent un levier essentiel dans le fonctionnement des structures médico-sociales.

Enfin, la nature du public accueilli, caractérisé par une forte dépendance et la présence de troubles cognitifs, souligne la complexité croissante de la prise en charge. Cette évolution des profils des résidents implique une adaptation constante des pratiques professionnelles, ainsi qu'un renforcement des compétences des équipes.

Ainsi, cet entretien met en évidence l'importance de la professionnalisation des fonctions de direction et confirme que la complexification des besoins des résidents nécessite une organisation adaptée et des compétences renforcées.

Bibliographie

Arnal-Capdevielle, I. (2020). *Chapitre 7. Les ESMS intervenant auprès des personnes âgées. Dans Le droit des établissements et services médico-sociaux* (pp. 129–151). Presses de l'EHESP

Artois, P., Hamzaoui, M., & Léonard, D. (2017). *Vieillissement et société : Catégorisations, travail, politiques sociales.* Academia.

Cocquebert, L. (2012). *Le secteur social et médico-social depuis la loi HPST : Gouvernance, contrôle, création et financement des établissements et servic*es (ASH Editions).

Horvath, G., & Touzé, V. (2024). *Une France vieillissante face au défi de la perte d'autonomie*. Dans L'économie française 2025 (ss la dir. de l'Observatoire français des conjonctures économiques, pp. 83-90). La Découverte.

Loubat, J.-R. (2020). *Penser le management en action sociale et médico-sociale* : 3e édition. Dunod

Ministère des Solidarités et de la Santé. (2020). *Ségur de la santé : les conclusions. Dossier de presse*, juillet 2020.

Perez-Roux, T., Maleyrot, É., Guyet, D., Balas, S., Orly, P., & Monceau, G. (2024). Chapitre 5. Former, se former, mettre en œuvre des collaborations interprofessionnelles et/ou avec les personnes concernées : enjeux, dispositifs, pratiques. Dans *Le travail de la relation* (pp. 153-172). Éditions Champ social.

Passerat, C., & Benoit, C. (2022). *Management* (3e éd., 304 p.). Gereso.

Santé publique France. (2025). *Bien vieillir*. Santé publique France.

Stratégie nationale de sante 2018-2022
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf

Terra Nova. (2018). *L'évolution des besoins en santé dans les décennies qui viennent.*

Toulemon, L., Algava, É., Blanpain, N., & Pison, G. (2022). *La population française devrait continuer de vieillir d'ici un demi-siècle. Population et Sociétés,* (597).

Annexe

Annexe 1 : Le guide d'entretien

Guide d'entretien		
Thèmes	**Objectifs/écarts**	**Questions**
Présentation de personne interrogées	Situer le profil et la structure d'établissement	Pouvez-vous vous présenter ? Quelle formation professionnelle avez-suivies ? Comment êtes-vous arrivé(e) à occuper ce poste ? Quel type d'établissement ou de service dirigez-vous ? Quels publics accompagnez-vous ? Quelles sont vos principales missions ? Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'établissement ?
Organisation de la gouvernance	Rôle des cadres intermédiaires Implication des professionnels	Comment est organisée la gouvernance de votre structure face à l'accroissement des besoins et à la diversification des publics ? Comment ces évolutions ont-elles transformé le fonctionnement de l'établissement ? Comment se déroule la collaboration entre les différents métiers/professionnels ? Dans quelle mesure la mutualisation des ressources optimise le fonctionnement ? Quels sont les freins et leviers à cette collaboration ?

Développement des compétences managériales	L'impact des compétences et de la formation sur la capacité d'adaptation aux besoins	Quels sont, selon vous, les principaux enjeux managériaux dans votre établissement aujourd'hui ? Ces enjeux sont-ils liés à des évolutions réglementaires, organisationnelles ou sociétales ? Quels critères ou compétences managériales recherchez-vous en priorité lors de recrutement ? Quelles actions concrètes mettez-vous en œuvre pour fidéliser les professionnels (reconnaissance, évolution de carrière, etc.) Quelles compétences managériales sont indispensables pour diriger un ESMS ? Comment ces compétences évoluent-elles avec les transformations du secteur ? La formation continue permet-elle de répondre aux évolutions des besoins managériaux ? Quels effets observez-vous sur la qualité des accompagnements ?
Évaluation et perspectives d'amélioration	Identifier les leviers et freins pour faire évoluer la gestion	Quels leviers sont prioritaires pour améliorer la gestion et la coordination ? Quels obstacles restent difficiles à dépasser ?

Codage de grille d'entretien

Thèmes	Verbatim	Axes d'analyse et d'interprétation
Présentation de personne interrogées	« Je suis directrice… depuis deux ans… reconversion professionnelle »	Mise en évidence d'une diversification des profils de direction, révélant une évolution du métier
	« EHPAD de 88 résidents… 50 ETP… privé associatif »	Permet de contextualiser les contraintes organisationnelles et territoriales
Organisation de la gouvernance	« On est quatre cadres… CODIR »	Organisation basée sur la délégation et la structuration des responsabilités
	« On prend les décisions en équipe »	
	« Chaque cadre gère ses équipes »	
Développement des compétences managériales	Professionnalisation des fonctions « « Master de Direction obligatoire »	Renforcement des exigences de qualification pour les postes de direction
	Formation du personnel/ Formation continue : « On forme les personnels non diplômés »	Stratégie d'adaptation face à la pénurie de personnel qualifié
	Adaptation au terrain : « On ne peut pas avoir 100 % diplômés »	Tension entre exigences réglementaires et réalités du terrain
	Stratégies RH informelles « pour les remplaçants… bouche-à-oreille »	Adaptation pragmatique face à la pénurie de personnel
Organisation de la gouvernance	Gouvernance relationnelle : « Relations avec les familles et les résidents »	Importance du lien social dans la gestion

Évaluation et perspectives d'amélioration	Identifier les leviers : « Relance de la démarche qualité… COPIL »	Mise en place d'outils structurants pour améliorer la gestion
	Identifier les freins : « Résistance au changement »	Les habitudes professionnelles freinent les transformations
	« Travail en équipe de direction »	Le collectif constitue un facteur clé de réussite
	« Difficulté à changer les plannings »	Le poids des routines limite les évolutions
	« Urgences qui perturbent les projets »	Les contraintes opérationnelles limitent la planification stratégique
	« Manque de visibilité… virage domiciliaire »	Le secteur est en mutation, influencé par les politiques publiques